

1) Le Kyste hydatique du poumon :

- A. Est souvent de bon pronostic
- B. Guérit spontanément
- C. Se calcifie souvent
- D. Peut se compliquer
- E. Est de traitement essentiellement chirurgical

Réponse :

2) Le Kyste hydatique du poumon :

- A. Est une pathologie chirurgicale
- B. Est secondaire à une bactérie qui se développe dans le poumon
- C. Est la première localisation chez l'enfant
- D. Peut être traité par chirurgie mini-invasive
- E. Peut diminuer en taille et disparaître sous traitement médical par Albendazole

Réponse :

3) Les facteurs incriminés dans l'hyper endémicité de l'hydatidose en Tunisie sont :

- A. La fréquence des chiens errants non surveillés
- B. Le climat sec
- C. La densité du réservoir canin
- D. L'abattage non contrôlé des moutons
- E. Le respect des conditions d'hygiène dans les abattoirs

Réponse :

Objectif 1 : Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.

4) Le kyste hydatique du poumon :

- A. Représente la première localisation chez l'adulte
- B. Touche surtout les sujets âgés
- C. Est plus fréquent chez les hommes que les femmes
- D. Peut être associé à des localisations extra pulmonaires
- E. Est toujours associé à une localisation hépatique

Réponse :

5) Les facteurs d'hyper endémicité hydatique en Tunisie sont :

- A. L'intensité d'élevage traditionnel en milieu rural Tunisien
- B. La densité du réservoir bovin
- C. La difficulté de ramassage des carcasses des ruminants décédés
- D. L'abattage non contrôlé surtout en zone rurale
- E. Le climat tempéré en Tunisie

Réponse :

Objectif 2 : Expliquer le cycle du parasite *Echinococcus Granulosus* et les modes d'infestation de l'homme.

6) L'Echinococcus Granulosus :

- A. Appartient à la classe des Nématodes
- B. Présente 3 formes évolutives
- C. Vit dans l'intestin grêle de l'homme sous sa forme adulte
- D. A une longévité de quelques jours
- E. Possède un premier anneau qui est germinatif dans son corps

Réponse :

7) L'Echinococcus Granulosus :

- A. Est un métazoaire appartenant à la classe des Cestodes
- B. Présente cinq formes évolutives différentes
- C. Vit dans les intestins du chien
- D. Présente une taille pouvant atteindre 1 mètre
- E. Est formé par 3 parties : une tête, un cou et un corps

Réponse :

8) Les œufs du parasite Echinococcus Granulosus :

- A. Représentent la forme infestante pour l'homme
- B. Sont libérés par le dernier anneau du corps de la forme adulte
- C. Peuvent être trouvés dans le pelage du chien
- D. Sont résistants dans le milieu extérieur
- E. Gagnent la circulation sanguine par voie lymphatique

Réponse :

9) Les œufs du parasite Echinococcus Granulosus :

- A. Comportent une coque externe embryophore
- B. Sont au nombre de 10 à 20 dans l'anneau germinatif
- C. Sont résistants dans le milieu extérieur
- D. Contiennent l'embryon hexacanthé
- E. Ont une longévité de quelques heures

Réponse :

10) La contamination de l'homme lors de l'hydatidose se fait par :

- A. Voie orale
- B. Voie sanguine
- C. Voie respiratoire
- D. Voie sexuelle
- E. Voie percutanée

Réponse :

11) La contamination humaine par le parasite Echinococcus Granulosus peut se faire par :

- A. Voie trans-cutanée
- B. Voie sanguine
- C. Voie orale
- D. Ingestion de viande de mouton contaminée
- E. Ingestion des œufs contenus dans le pelage d'un chien contaminé

Réponse :

12) La forme larvaire du parasite Echinococcus Granulosus :

- A. Est la forme de dissémination du parasite
- B. Se développe chez l'hôte définitif
- C. Peut être unique ou multiple
- D. Contient les protoscolex
- E. Est caractérisée par une très grande résistance dans le milieu extérieur

Réponse :

13) La contamination de l'homme par le parasite Echinococcus Granulosus peut se faire suite à :

- A. Un contact avec des chiens contaminés par la forme adulte
- B. Une ingestion de viande de mouton mal cuite
- C. Une ingestion de légumes frais contaminés par les déjections d'un chien infecté
- D. Une manipulation d'un kyste hydatique rompu chez le mouton
- E. Une consommation d'eau de puit contaminée par les déjections d'un chien infecté

Réponse :

14) Le parasite Echinococcus Granulosus :

- A. Se présente sous la forme adulte chez l'hôte intermédiaire
- B. Se présente sous la forme adulte chez l'hôte définitif
- C. Se présente sous la forme adulte chez l'hôte accidentel
- D. A une forme globale d'un ver allongé
- E. Est composé de trois anneaux et une tête

Réponse :

Objectif 3 : Décrire l'aspect anatomo-pathologique du kyste hydatique au cours de ses différentes phases évolutives.

Objectif 4 : Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.

Cas clinique 1 :

Vous voyez en consultation une jeune fille de 16ans, originaire de Kairouan et qui présente une toux avec douleur thoracique ainsi que des hémoptysies de faible abondance depuis 2 jours. Une radiographie de thorax de face et de profil a montré une opacité ronde de 7cm du lobe inférieur droit surmontée d'un croissant aérien.

Question 1 : Quel est l'aspect radiologique décrit ?

Question 2 : Quelle est la notion qu'il faudrait rechercher à l'interrogatoire devant cette présentation clinique ?

Cas clinique 2 :

Patient âgé de 21 ans, originaire de sidi Bouzid, sans antécédents pathologiques particuliers, consulte pour douleur thoracique, toux et crachats hémoptoïques. une radiographie de thorax faite a objectivé la présence d'une opacité de 5 cm homogène, périphérique, arrondie et de tonalité hydrique au niveau du lobe inférieur du poumon droit.

Question 1 : Quel est le diagnostic le plus probable ?

Question 2 : Quel examen complémentaire demanderiez- vous systématiquement ?

15) Chez l'homme, le développement d'un kyste hydatique du poumon expose aux complications suivantes :

- A. La calcification
- B. La rupture dans les bronches
- C. La rupture dans la plèvre
- D. La compression bronchique avec atélectasie
- E. La surinfection

Réponse :

Cas clinique 3 :

Monsieur A.K âgé de 30 ans, originaire de Siliana, consulte les urgences pour toux avec expectorations à goût salé, mélangées à des débris blanchâtres.

Il n'a pas d'antécédents particuliers. Il est berger de profession.

L'examen physique est sans particularités.

La radiographie thoracique de face montre un aspect en faveur d'un kyste hydatique compliqué du lobe inférieur droit et périphérique mesurant 3 cm.

16) La radiographie thoracique de ce patient peut montrer :

- A. Une image en boulet de canon
- B. Une image en grelot
- C. Une cavité aérique
- D. Un aspect en nénuphar
- E. Un niveau hydro aérique

Réponse :

17) Un kyste hydatique fissuré est traduit radiologiquement par :

- A. Une image en boulet de canon
- B. Le signe de nénuphar
- C. Une image de rétention de membrane
- D. Un niveau hydro-aérique
- E. Un croissant gazeux surmontant une opacité ronde

Réponse :

18) La rupture intra pleurale d'un Kyste Hydatique du poumon :

- A. Est une complication fréquente
- B. Peut être aigüe ou insidieuse
- C. Peut être responsable d'une hydatidose pleurale primitive
- D. Peut être responsable d'une hydatidose pleurale secondaire
- E. Peut être responsable d'un pneumothorax

Réponse :

19) L'hydatidose pulmonaire secondaire :

- A. Est fréquente
- B. Résulte de la migration d'un Embryon Hexacanthé
- C. Peut être métastatique par rupture d'un kyste dans un vaisseau
- D. Peut résulter d'un ensemencement endobronchique
- E. Peut être la conséquence d'une rupture directe d'un kyste dans une séreuse

Réponse :

Objectif 5 : Planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic et au bilan d'extension du kyste hydatique du poumon.

20) Le kyste hydatique du poumon fissuré :

- A. Est rarement observé
- B. Résulte d'une évolution naturelle du kyste
- C. Est secondaire au passage d'air dans l'hydatide
- D. Réalise sur la radiographie thoracique l'image en Nénuphar
- E. Est pathognomonique du Kyste Hydatique du poumon

Réponse :

21) Quel(s) est (sont) le(les) aspect(s) radiologique(s) pathognomonique(s) d'un kyste hydatique pulmonaire sur la radiographie thoracique ?

- A. Aspect en Boulet de Canon
- B. Aspect de double croissant gazeux d'Ivassinevitch
- C. Aspect en Grelot
- D. Aspect en Nénuphar
- E. Aspect de Pneumokyste

Réponse :

Objectif 6 : Discuter les principaux diagnostics différentiels en fonction des stades évolutifs du kyste hydatique du poumon.

22) Le traitement d'un kyste hydatique de 8 cm rompu et surinfecté du lobe inférieur droit associé à des hémoptysies de faible abondance, devrait inclure :

- A. L'administration de Dycinone en intra veineux
- B. Une kystectomie chirurgicale selon la technique de Barrett
- C. Une énucléation chirurgicale
- D. Un traitement anti helminthique
- E. Un traitement antibiotique

Réponse :

Cas clinique 3 = 4 :

Monsieur A.K âgé de 30 ans, originaire de Siliena, consulte les urgences pour toux avec expectorations à goût salé, mélangées à des débris blanchâtres. Il n'a pas d'antécédents particuliers. Il est berger de profession. L'examen physique est sans particularités. La radiographie thoracique de face montre un aspect en faveur d'un kyste hydatique compliqué du lobe inférieur droit et périphérique mesurant 3 cm.

23) Le traitement chirurgical idéal à proposer pour ce patient est :

- A. Une résection pulmonaire atypique (Wedge)
- B. Une kystectomie selon la technique de Ugon
- C. Une pneumonectomie
- D. Une lobectomie
- E. Une segmentectomie

Réponse :

24) Le geste chirurgical pour le traitement d'un kyste hydatique périphérique de 3cm du lobe inférieur gauche peut être réalisé par :

- A. Une thoracotomie postérolatérale gauche (T PL)
- B. Une chirurgie thoracique gauche vidéo-assistée (VATS)
- C. Une chirurgie par vidéothoracoscopie uniportale exclusive gauche (U-VATS)
- D. Une médiastinoscopie
- E. Une sternotomie médiane

Réponse :

25) La chirurgie du kyste hydatique selon la technique de « UGON » :

- A. Est la technique utilisée pour le traitement des kystes périphériques de petite taille
- B. Est la technique utilisée pour le traitement des kystes infectés
- C. Est la technique utilisée pour traitement des kystes rompus dans la plèvre
- D. Consiste à la ponction-aspiration du kyste et extraction de la membrane proligère
- E. Peut ne pas nécessiter de capitonnage de la cavité résiduelle

Réponse :

26) Devant un kyste hydatique, la périkystectomie :

- A. Consiste à ponctionner le kyste et à enlever la membrane proligère
- B. Consiste à effectuer une résection de tout le kyste avec les tissus avoisinants
- C. Est une technique utilisée pour la stérilisation du kyste
- D. Est souvent très hémorragique
- E. Est utilisée pour le traitement des kystes simples

Réponse :

27) Le traitement chirurgical d'un kyste hydatique compliqué du poumon :

- A. S'impose dès que le diagnostic est établi
- B. Implique l'utilisation systématique d'une solution scolicide
- C. Peut se résumer à l'utilisation de la technique de Barrett
- D. Peut associer une périkystectomie
- E. Ne comporte pas de complications post opératoires

Réponse :

28) La technique de Barrett :

- A. Est proposée dans le traitement chirurgical du kyste hydatique du poumon
- B. Consiste à réaliser une évacuation de vésicule hydatique sans l'ouvrir par accouchement
- C. Nécessite l'utilisation d'une solution scolicide
- D. Consiste à réaliser une résection du dôme saillant du foie
- E. Est toujours utilisée pour les kyste hydatiques périphériques

Réponse :

29) Les solutions scolicides pouvant être utilisées durant la chirurgie d'un kyste hydatique du poumon sont :

- A. La povidone iodine (Bétadine)
- B. L'eau oxygénée
- C. Le nitrate d'argent
- D. Le sérum glucosé à 30%
- E. Le sérum salé hypertonique

Réponse :

30) Le traitement de la cavité résiduelle d'un KHP peut inclure :

- A. Une résection pulmonaire atypique (Wedge)
- B. Une fermeture de plusieurs fistules bronchiques
- C. Une périkysectomie
- D. Une périkycto-résection
- E. Une kystectomie selon la technique de Barrett

Réponse :

31) La chirurgie du kyste hydatique du poumon :

- A. Est toujours proposée dès qu'on suspecte le diagnostic
- B. Associe un traitement du parasite plus ou moins un traitement de la cavité résiduelle
- C. Peut consister en une résection wedge du poumon pour les petits kystes centraux
- D. Peut parfois nécessiter une exérèse anatomique du genre : lobectomie
- E. Peut associer une décortication en cas de kyste infecté rompu dans les plèvres

Réponse :

32) Le traitement chirurgical d'un kyste hydatique central de 8cm de diamètre et rompu dans les bronches du lobe inférieur droit peut être :

- A. Une lobectomie inférieure droite
- B. Une résection atypique pulmonaire (wedge)
- C. Une kystectomie selon la technique de Barrett + capitonnage de la cavité
- D. Une énucléation selon la technique de Ugon
- E. Une décortication pulmonaire

Réponse :

Objectif 13 : Décrire les moyens de prévention du kyste hydatique :

33) Les mesures d'hygiène à proposer chez un patient afin d'éviter une éventuelle récurrence sont :

- A. Bien cuire la viande avant consommation
- B. Vacciner les personnes à risque
- C. Traiter les chiens infestés
- D. Assurer une bonne hygiène des mains
- E. S'assurer de bien laver les crudités

Réponse :